CUIDADOS INTENSIVOS MONITORIZACIÓN EN UCI

DR. ALFREDO MATOS

MONITOREO HEMODINÁMICO

- Línea arterial: presión arterial continua y acceso para gasometrías seriadas.
- Catéter venoso central: medición de presión venosa central y administración de vasopresores.
- Metas: presión arterial media ≥65 mmHg y diuresis ≥0.5 mL/kg/h como marcadores de perfusión adecuada.

MONITOREO RESPIRATORIO

- Ventilación mecánica: volumen corriente 6 mL/kg de peso ideal; ajustar PEEP según la oxigenación.
- Gasometría arterial seriada para evaluar oxigenación y ventilación.
- Destete: pruebas de respiración espontánea diarias cuando el paciente lo tolera.

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES

- Profilaxis de TEV y de úlceras de estrés en todo paciente crítico.
- Cabecera elevada 30-45° para prevenir neumonía asociada al ventilador.
- Revisión diaria de catéteres y líneas, para retirarlos tan pronto como ya no sean necesarios.

SEDACIÓN Y DELIRIO

- Escala RASS para medir el nivel de sedación objetivo (idealmente ligero, no profundo).
- Interrupción diaria de la sedación cuando sea posible, para evaluar el estado neurológico.
- Delirio en UCI: tamizaje con CAM-ICU; se previene con movilización temprana y orientación.

ESCALAS DE GRAVEDAD EN UCI

- APACHE II y SOFA estiman la gravedad y el riesgo de mortalidad del paciente crítico.
- Se recalculan según la evolución del paciente para ajustar el manejo.



Actualización SOFA-2 Score

Sistema	0	1	2	3	4
Neurológico (GCS)	15	13-14 o uso de fármacos para delirium	9-12	6-8	3-5 o ausencia de respuesta motora
Respiratorio PaO_2/FiO_2	>300	≤300	≤225	≤150 + **soporte vent. avanzado**	≤75 + **soporte avanzado** o ECMO
Cardio-vascular	PAM ≥70, sin vasopresores	PAM <70 sin vasopresores	NorEpi/Epi ≤0.2 µg/kg/min u otro soporte	NorEpi/Epi >0.2-0.4 µg/kg/min **u otro soporte** ≤0.2	NorEpi/Epi >0.4 µg/kg/min **o** soporte circulatorio
Hígado (Bilirrubina mg/dL)	≤1.2	≤3	≤6	≤12	>12
Riñón	Cr ≤1.2 mg/dL	Cr ≤2 mg/dL o diuresis <0.5 mL/kg/h x 6-12h	Cr ≤3.5 mg/dL o diuresis <0.5 mL/kg/h ≥12h	Cr >3.5 mg/dL o diuresis <0.3 mL/kg/h ≥24h o anuria ≥12h	Diálisis aguda o crónica / cumple criterios para RRT
Hematología (Plaquetas)	>150,000	≤150,000	≤100,000	≤80,000	≤50,000

FOCOS DE SEPSIS

- Más frecuentes: pulmón (1.°) y cavidad intraabdominal (2.°).
- El retraso en el control del foco es la principal causa de mortalidad en sepsis intraabdominal (hasta 82% más); cada hora sin antibióticos empíricos reduce la sobrevida.

CUIDADOS INTENSIVOS Y MONITORIZACIÓN EN UCI

DR. ALFREDO MATOS

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

- Tipo 1 (hipoxémica) y tipo 2 (hipercápnica); Glasgow ≤8: intubación absoluta para proteger la vía aérea.

INTUBACIÓN PROFILÁCTICA EN EL QUEMADO

- Quemaduras faciales o inhalación (vibrisas chamuscadas, esputo carbonáceo): intubar antes de que el edema lo impida, aun con gases normales.

SDRA

- Inflamación difusa de la membrana alvéolo-capilar: exudado proteináceo, membrana hialina e inactivación del surfactante.
- Disnea, infiltrados bilaterales en parche e hipoxemia refractaria: ventilación protectora con PEEP alta (10–18 cmH2O).



METAS DE REANIMACIÓN

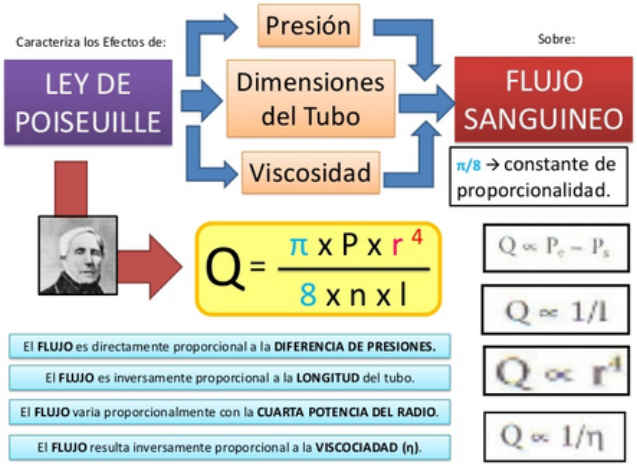
- PAM ≥65 mmHg y aclaramiento de lactato >10% en controles seriados (normal <2 mmol/L).

VASOPRESOR DE ELECCIÓN

- Norepinefrina; puede iniciarse por vía periférica temporalmente mientras se coloca un acceso central.

LEY DE POISEUILLE

- Flujo proporcional a r^4 e inverso a la longitud: dos periféricos cortos y gruesos (14–16G) dan más caudal que un catéter venoso central.



SOLUCIONES DE REANIMACIÓN

- Cristaloides (Lactato de Ringer o SSN 0,9%) sobre coloides; dextrosa 5% contraindicada para expansión (pasa al intersticio).

SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL

- PIA normal <8 mmHg; hipertensión intraabdominal >12; SCA: PIA ≥20 con nueva disfunción orgánica.
- Descompresión quirúrgica urgente: abdomen abierto (bolsa de Bogotá o VAC).



COMUNICACIÓN Y FAMILIA

- Mantener informada a la familia sobre el pronóstico y los objetivos de cuidado reduce la ansiedad y mejora la toma de decisiones compartidas.